

INTOXICACIÓN POR PRODUCTOS DE USO DOMÉSTICO

Jens Juan Grünewald Ortiz, Marta Sainz de Andueza, Cristina Güemes de la Iglesia.

INTRODUCCIÓN

Los productos de limpieza doméstica constituyen, después de los medicamentos y las sustancias de abuso, la tercera causa más frecuente de intoxicación en adultos, y la primera en menores de 5 años.

La exposición a estas sustancias es frecuente por su fácil disponibilidad pudiendo ser la intoxicación accidental (90% de los casos, en gran número por almacenamiento incorrecto) o voluntaria (fines autolíticos).

La mayoría de ellas darán escasa o nula sintomatología, salvo la ingesta voluntaria de cáusticos en adultos que, por su gravedad, tiene una alta mortalidad.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA CAÚSTICOS

Los productos de uso doméstico cáusticos pueden ser **álcalis**: amoníaco, hidróxido sódico o potásico (sosa cáustica, detergentes, limpiahornos), hipoclorito sódico (lejía), sales sódicas (lavavajillas de maquina) o **ácidos**: ácido clorhídrico (sulfumán, limpiadores de WC), ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido oxálico (pulidores de muebles), ácido nítrico (aguarrás).

Clínica: dependerá de la dosis, tipo de sustancia, el tiempo de contacto y el tipo de exposición. Produce lesiones de carácter irritativo que pueden evolucionar rápidamente creando úlceras y necrosis con secuelas irreversibles. Depende de la vía de entrada:

- Vía oral: lesiones en esófago y estómago. Si es leve: quemazón, dolor en labios, lengua, boca, faringe, región esternal y epigástrica, acompañado de vómitos y sialorrea. Se observan lesiones en boca y faringe. Si es grave: perforación gástrica o esofágica, hemorragia digestiva, hipotensión, taquicardia, disnea, cianosis, acidosis metabólica, shock que puede evolucionar a fallo multiorgánico y muerte en pocas horas.
- Vía respiratoria (por inhalación de vapores): irritación faríngea y laríngea, edema de glotis, broncoespasmo, edema pulmonar no cardiogénico.
- Vía cutánea: quemaduras en piel y oculares.

Ante la presencia de lesiones orofaríngeas, la endoscopia digestiva en las primeras 12-24 horas es la exploración clave para predecir la extensión, gravedad de las lesiones y actitud a seguir (contraindicada si sospecha de perforación). También se debe incluir una Rx. de tórax y abdomen y/o TAC toracoabdominal si se sospecha perforación, además de una analítica completa.

Si no se objetivan lesiones orofaríngeas, el paciente se encuentra asintomático y la exploración es normal tras 2 horas de observación, no es necesaria la realización de endoscopia.

Tratamiento:

- Medidas generales de soporte vital y estabilización con aislamiento de vía aérea si es necesario antes de que aparezca el edema.
- Dieta absoluta. Contraindicado inducir al vómito, el lavado gástrico y la utilización de neutralizantes (bicarbonato, vinagre, limón) y/o carbón activado.
- Si el tiempo transcurrido desde la ingesta es <1h, dilución gástrica con agua albuminosa, leche o agua fría (250 ml). Ineficaz si el tiempo transcurrido desde la ingesta es mayor.

- Tratar las posibles complicaciones (hemorragia digestiva, broncoespasmo)
- Se aconseja la administración de antieméticos (ondansetrón 4-8 mg/6h iv), inhibidores de la bomba de protones (IBP) (omeprazol 40 mg/24h iv) y analgesia con opiáceos.
- Los corticoides (metilprednisolona 60 mg/24h durante 3 semanas) y la antibioterapia de amplio espectro están discutidos, pero se recomiendan en lesiones endoscópicas con ulceración profunda, múltiple y/o necrosis (Grados II o III de Zargar) para disminuir las secuelas en forma de estenosis.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA NO CAÚSTICOS

Incluyen detergentes, lavavajillas y jabones para lavado manual, suavizantes de ropa, limpiasuelos, limpiacalzados con agentes tensioactivos aniónicos y no iónicos. Suelen tener escasa toxicidad.

Clínica: a nivel cutáneo pueden producir irritación con reacciones de hipersensibilidad o conjuntivitis. Si ingesta, molestias gastrointestinales leves con picor bucal, náuseas, vómitos y diarrea. En raras ocasiones estridor, neumonitis y crisis asmáticas tras inhalación accidental de detergentes en polvo.

Las sustancias con agentes tensioactivos catiónicos (suavizantes concentrados) pueden dar lugar a síntomas a nivel del SNC: confusión, agitación, debilidad, ataxia, síntomas de embriaguez y disminución del nivel de conciencia.

Los detergentes con quelantes de calcio (polifosfatos) pueden dar hipocalcemia con tetania, arritmias o lesiones renales

Tratamiento:

- No indicada la realización de descontaminación gástrica. No provocar la emesis o utilización de carbón activado.
- Lavado en arrastre con agua o suero fisiológico abundante durante 15 min. a nivel cutáneo y ocular y posterior valoración oftalmológica si queratoconjuntivitis.
- Dilución con agua, leche o agua albuminosa
- Tratamiento sintomático. Gluconato cálcico si hay hipocalcemia.

INTOXICACIÓN POR HIDROCARBUROS

Son compuestos presentes en multitud de sustancias de uso común (disolventes, abrillantadores, quitamanchas, enceradores, colas, tintas, pegamentos...).

La vía más frecuente de intoxicación es la inhalatoria, pero también es posible por vía cutánea y digestiva. Los más volátiles y, por tanto, más peligrosos, son los disolventes y los combustibles.

Clínica:

- Aparato respiratorio: quemazón a nivel de boca, faringe y laringe, sensación de ahogo. Si broncoaspiración, taquipnea, sibilantes, roncus con hipoxemia y cianosis. Posibilidad de neumonía lipoidea.
- SNC: cefalea, mareo, ansiedad, depresión del SNC, somnolencia, estupor e incluso coma. En ocasiones convulsiones.
- Hepatorenal: hepatotoxicidad. Glomerulonefritis.
- Hemólisis moderada. Si exposición reiterada, aplasia medular. Dermatitis y quemaduras en

exposición cutánea. Miopatía con elevación de CPK. Arritmias en ocasiones.

Diagnóstico:

- Analítica general con parámetros hepático y renal. Gasometría arterial.
- Rx. de tórax. Pudiendo objetivar neumonitis. En ocasiones derrame pleural.
- ECG: valorar arritmias o signo de isquemia secundarios a hipoxia.

Tratamiento:

- Soporte vital básico y tratamiento sintomático.
- Si ingesta grande, descontaminación con SNG y aspiración (no lavado posterior).
- Si persiste cianosis a pesar de corrección de hipoxemia, pensar en metahemoglobinemia (administrar azul de metileno).

COSMÉTICOS.

La mayoría no son tóxicos si no se ingieren en grandes cantidades. Su clínica es leve o incluso asintomática.

Se pueden distinguir 4 grupos:

- **Productos sin toxicidad:** cremas y lociones corporales, dentífricos, desodorantes sin alcohol, productos de maquillaje. No necesitan tratamiento.
- **Productos de baja toxicidad:** champú, gel de baño, espuma de afeitar. Si clínica digestiva administrar antiácidos y/o antidiarreicos.
- **Productos con toxicidad por alcohol:** colonias, desodorantes con alcohol, loción de afeitado. Con tratamiento similar a los cuadros de intoxicación etílica.
- **Productos potencialmente tóxicos:** tintes, quitaesmaltes, depilatorios, sales de baño. Clínica: gastrointestinal y sistémica. Tratamiento: recomendable la descontaminación digestiva salvo contraindicación y tratamiento sintomático.

OTROS PRODUCTOS DOMÉSTICOS

Antipolillas

Compuestos por paradiclorobenceno (PDB) o naftaleno.

Clínica: absorción rápida. Irritación de mucosas, náuseas y vómitos, a veces fiebre y diarrea. En dosis altas (más de una bola), letargo, convulsiones, orina oscura y metahemoglobinemia. El naftaleno produce anemia hemolítica 1-3 días postexposición. En casos graves se objetivan trastornos cardiovasculares, hiperpotasemia, insuficiencia renal y hepatotoxicidad.

Tratamiento: Si menos de 4 horas desde la ingesta, lavado gástrico con carbón activado. Contraindicada la leche, aceites y derivados. Si metahemoglobinemia, oxigenoterapia y azul de metileno (2mg/kg en solución al 1% iv lento). Control de hemólisis. Tratamiento sintomático de las complicaciones.

Pilas Alcalinas

Pueden estar compuestas de hidróxido sódico o potásico, óxido de zinc, cadmio, plata o mercurio.

Clínica: si la pila es nueva, puede producir quemaduras eléctricas al cerrarse el circuito con la humedad de las mucosas. Si la pila es usada no se produce este efecto, pero si se abre al tubo

digestivo produce quemaduras químicas.

Aparecen dolores abdominales, vómitos, malestar general, hipotensión arterial y colapso. A veces síntomas renales y hepáticos.

Realizar Rx. posteroanterior y lateral de tórax y Rx.de abdomen para ver localización y número.

Tratamiento: en la mayor parte de los casos se elimina con las heces con facilidad. Dieta rica en fibra vegetal y laxantes. En caso de impactación o complicaciones, extracción vía endoscópica o quirúrgica según localización. Administrar IBP.

Ambientadores Líquidos Concentrados

Compuestos por alcohol etílico, perfumes, colorantes y emulsionantes.

Clínica: irritación leve de piel y mucosas por contacto. Si ingesta, irritación gastrointestinal. Ante ingesta elevada: embriaguez, alteraciones metabólicas (acidosis e hipoglucemia) y lesión renal.

Tratamiento: lavado en arrastre con agua abundante. Si ingesta, administrar líquidos azucarados abundantes. Lavado gástrico y carbón activado. Vigilar el equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico, control de glucemia e hidratación del paciente. Vigilar posibles síntomas neurológicos. Descartar posible lesión renal. No provocar el vómito.

Repelentes De Insectos

Compuestos fundamentalmente por dietiltoluidamida (DEET).

Clínica: toxicidad neurológica (convulsiones, encefalopatía, coma); afectación sistémica (hipotensión, vómitos, bradicardia, hepatitis).

Tratamiento: No administrar antieméticos. Carbón activado o lavado gástrico. Lavado cutáneo si es esta la vía de intoxicación.

PUNTOS CLAVE

- El lavado gástrico, provocar el vómito y la administración de carbón activado generalmente es innecesario y en muchas situaciones contraindicado (cáusticos).
- El mejor tratamiento es la prevención (etiquetado correcto, uso de envases adecuados...)
- En caso de duda terapéutica está disponible las 24h del día, los 365 días del año el Servicio de Información Toxicológica. (Teléfono para profesionales sanitarios: **91 4112676**)

BIBLIOGRAFÍA

- Grünewald J, Callado FJ, Martín C. Intoxicación por productos de uso doméstico. En: Urgencias en Medicina. 5ª Ed. Burgos. Ed. Berceo. 2012. 699-706.
- Instituto Nacional de Toxicología. Productos de limpieza y mantenimiento de uso doméstico. Disponible en: <http://www.mju.es/toxicologia/intoxicaciones/productolimpieza.htm>
- Rodríguez R, Calderón A, Pérez A, Alonso A, Martínez S, Vasserot FJ. Intoxicaciones por productos domésticos y productos industriales. En: Tratado de Medicina Intensiva. Barcelona. Ed. Elsevier. 2017. Capítulo 107. 713-716.
- Dueñas Laita, A. Intoxicaciones agudas en medicina de urgencias y cuidados críticos. Barcelona. Ed. Mason S.A. 1999.
- Nogué S, Salgado E. Intoxicación por productos domésticos. En: Medicina Interna. Farreras Rozman. 18ª Ed. Barcelona. Ed. Elsevier. 2016. 2475-2479.

- Claudet I. Intoxicaciones domésticas accidentales en la infancia. Tratado EMC. Pediatría. Barcelona. Elsevier Mason SAS. 2015. Volumen 50, Número 4. 1-19.